FIKTIVNÍ PACIENTKA – testovací data pro Rakathon 2026

Strukturovaný handover – podklad pro MDT

MDT:	MDT pro nádory GIT, 21. 10. 2026
Stav dokumentace k:	20. 10. 2026 · zprávy 01–11 (zprávy 12 algeziologie 26. 10. a 13 psychologie 27. 10. vznikly po MDT – nezahrnuty)
Referující lékař:	MUDr. Tomáš Řezníček, praktický lékař, Na Návsi 3, 252 41 Dolní Břežany, tel. +420 311 000 287
Vypracovala:	Bc. Lucie Dvořáková, koordinátorka KOC (AI návrh, ověřeno koordinátorkou)

Údaje převzaty bez domýšlení. NEUVEDENO = údaj v dokumentaci chybí, NESOULAD = zprávy si odporují – ověřit.

1 Nacionále pacienta

Jméno:	Alena
Příjmení:	Procházková
Věk:	63 let (nar. 22. 7. 1963), RČ 635722/1013
Pohlaví:	žena
Zdravotní pojišťovna:	211

2 Kontakty

Pacientka:	tel. +420 777 000 541 · Za Školou 17, 252 41 Dolní Břežany
E-mail:	NEUVEDENO
Kontaktní osoba:	Petra Horká (dcera), tel. +420 777 000 542 – pacientka souhlasí se sdílením informací

3 Diagnóza

C25.0 – duktální adenokarcinom hlavy pankreatu, G2–G3, s perineurální invazí (histologie 19. 10. 2026); CT bez vzdálených metastáz

Zdroj: 11 Histologie KOC 2 19. 10. · 08 CT KOC 1 8. 10.

4 Epikríza (stručný souhrn nemoci)

63letá pacientka, od poloviny srpna 2026 bolesti v epigastriu, teploty a tmavá moč, 1. 9. cholestáza a zánětlivá aktivita (léčena ciprofloxacinem). UZ 29. 9.: ložisko hlavy pankreatu 34 × 30 mm. CT 8. 10. (KOC 1): tumor 35 × 31 mm, kontakt s VMS asi 200° se zúžením, s AMS do 150°, suspektní peripankreatická uzlina, bez metastáz. EUS-FNB 12. 10., histologie: duktální adenokarcinom G2–G3.

Zdroj: 04 Epikríza PL 4. 9. · 05 Gastroenterologie 15. 9. · 06 UZ břicha 29. 9. · 08 CT KOC 1 8. 10. · 09 EUS-FNB KOC 2 12. 10. · 11 Histologie KOC 2 19. 10.

5 Požadavek / otázka na MDT

Z žádosti PL: dokončení diagnostiky a stanovení dalšího postupu v rámci MDT. Konkrétní otázka na MDT neuvedena; PL o doplnění požádán 2. 10., bez odpovědi.

NEUVEDENO: konkrétní otázka na MDT neuvedena

Zdroj: 07 Žádost PL 2. 10.

6 Komorbidity (OA)

I48.0 paroxysmální fibrilace síní (CHA_2DS_2-VASc 2, HAS-BLED 1) na antikoagulaci, I10 arteriální hypertenze, E78.0 hypercholesterolémie; echo 20. 7.: EF LK 60 %. St. p. hysterektomii (2010), 2019 přechodně depresivní ladění, neléčena.

Zdroj: 01 Kardiologie Jesenice 20. 7. · 07 Žádost PL 2. 10.

7 Léková anamnéza (FA)

apixaban 5 mg 1-0-1 · bisoprolol 5 mg 1-0-0 · perindopril 4 mg 1-0-0 · rosuvastatin 10 mg 0-0-1 · paracetamol 500 mg při bolesti max. 4× denně

> **NESOULAD: apixaban: EUS 12. 10. uvádí „vysazen 48 h před výkonem (poslední dávka 18. 10.)“ – datum je po výkonu; obnovení „od 21. 10.“ ověřit u gastroenterologa**

Zdroj: 01 Kardiologie Jesenice 20. 7. · 07 Žádost PL 2. 10.

8 Alergie (AA)

neguje

Zdroj: 04 Epikríza PL 4. 9. · 07 Žádost PL 2. 10.

9 Stav výkonnosti (PS / Karnofského skóre)

Neuvedeno v žádné zprávě. Slovně: soběstačná (žádost PL 2. 10.); zátěž 2 patra bez zastavení (kardiologie 20. 7.).

> **NEUVEDENO: ECOG / Karnofsky neuveden – vyžádáno od PL 2. 10. a 19. 10.**

Zdroj: 07 Žádost PL 2. 10. · 01 Kardiologie Jesenice 20. 7.

10 Váha a výška

Výška 165 cm · hmotnost 69 kg (20. 7. 2026) → 65 kg (15. 9. 2026), úbytek 4 kg za měsíc. Aktuální hmotnost k MDT neuvedena.

> **NEUVEDENO: aktuální hmotnost neuvedena (poslední 15. 9.)**

Zdroj: 01 Kardiologie Jesenice 20. 7. · 05 Gastroenterologie 15. 9.

11 Symptomy nemoci a jejich počátek

Od poloviny srpna 2026 bolesti v epigastriu a pravém podžebří, později s propagací do zad, horší po jídle a v noci; přelom srpna/září teploty se zimnicí, tmavší moč, občas světlejší stolice; nechutenství, úbytek hmotnosti; výrazná úzkost, špatně spí.

Zdroj: 04 Epikríza PL 4. 9. · 05 Gastroenterologie 15. 9. · 07 Žádost PL 2. 10.

12 Provedená vyšetření

Datum	Místo provedení	Typ vyšetření	Popis výsledků (plné znění)
20. 7. 2026	Kardiologická ambulance Jesenice (MUDr. Petr Malý)	Kardiologická kontrola, EKG, orientační echo	Stabilní stav, sinusový rytmus, bez recidivy fibrilace síní. TK 132/80, TF 68/min. LK nedilatovaná, normální kinetika, EF LK 60 %, LS 42 mm, chlopně bez významné vady. Hypertenze kompenzovaná. Před plánovaným invazivním výkonem s vysokým rizikem krvácení vysadit apixaban 48 hodin předem, bez nutnosti překlenovací léčby.
3. 9. 2026	Radiologické centrum Modřany	RTG hrudníku PA	Plicní parenchym bez ložiskových a infiltrativních změn, hily nerozšířené, bránice hladká, kostofrenické úhly volné, srdeční stín nezvětšen. Závěr: bez známek zánětlivých změn plic.
15. 9. 2026	Poliklinika Jižní, gastroenterologie (MUDr. Ivana Křížová)	Gastroenterologické vyšetření	Tupé bolesti v epigastriu s propagací do zad, horší po jídle a v noci, nechutenství, úbytek hmotnosti 4 kg za měsíc (z 69 na 65 kg), tmavá moč, občas světlejší stolice. Subikterus sklér, břicho citlivé v epigastriu. Závěr: cholestatický syndrom; DD choledocholitiáza, stenóza žlučových cest, tumor pankreatu. Doporučeno UZ, dle výsledku CT (pankreatický protokol), případně EUS.
29. 9. 2026	Poliklinika Jižní, RDG pracoviště	UZ břicha	Intrahepatální žlučovody lehce dilatovány, DHC 10 mm, žlučník mírně distendovaný bez konkrementů. V hlavě pankreatu hypoechogenní nehomogenní neostře ohraničené ložisko 34 × 30 mm, ductus Wirsungi 4 mm. Vztah k portomezenterickému soutoku nelze UZ

			posoudit. Bez volné tekutiny. Závěr: ložisková léze hlavy pankreatu suspektní z malignity.
8. 10. 2026	KOC Nemocnice Severní, Radiologická klinika	CT břicha a hrudníku s k. l., pankreatický protokol	V hlavě pankreatu hypodenzní ložisko 35 × 31 mm. V. mesenterica superior obkružena asi 200° obvodu se zúžením lumen v délce 18 mm, proximální i distální segment vhodný k rekonstrukci; v. portae průchodná. Kontakt s a. mesenterica superior do 150° bez zúžení; truncus coeliacus a a. hepatica communis bez kontaktu; a. gastroduodenalis v kontaktu. DHC 11 mm. Peripankreatická uzlina 12 × 9 mm suspektní, paraaortální uzliny nezvětšené. Játra bez ložisek, bez ascitu. Hrudník bez ložiskových změn. Závěr: tumor hlavy pankreatu 35 mm s venózním postižením VMS a kontaktem s AMS, suspektní uzlina, bez vzdálených metastáz.
12. 10. 2026	KOC Nemocnice Lipová, endoskopie (MUDr. Martin Svoboda)	EUS-FNB ložiska hlavy pankreatu	Hypoechogenní nehomogenní ložisko hlavy pankreatu 33 × 29 mm, 3 průchody jehlou FNB 22G, dostatečné válečky tkáně. Bez komplikací. Příprava: „apixaban vysazen 48 h před výkonem (poslední dávka 18. 10. 2026 večer)“. Doporučení: apixaban znovu od 21. 10. 2026 ráno.

> **NESOULAD: apixaban: EUS 12. 10. uvádí „vysazen 48 h před výkonem (poslední dávka 18. 10.)“ – datum je po výkonu; obnovení „od 21. 10.“ ověřit u gastroenterologa**

13 Laboratorní výsledky včetně onkomarkerů

Vyšetření	1. 9. 2026 (LabJih)	15. 10. 2026 (KOC 2)	Jednotky
Leukocyty	12,8 ↑	8,9	10^9/l
Hemoglobin	124	118 ↓	g/l
Trombocyty	298	312	10^9/l
Bilirubin celkový	38 ↑	23 ↑	µmol/l
ALT	1,92 ↑	1,62 ↑	µkat/l
AST	1,45 ↑	1,20 ↑	µkat/l
GGT	4,20 ↑	5,00 ↑	µkat/l
ALP	3,10 ↑	3,40 ↑	µkat/l
Albumin	–	36	g/l
CRP	86 ↑	18 ↑	mg/l
Kreatinin	78	74	µmol/l
CA 19-9	neprovedeno	312 ↑	kU/l
CEA	neprovedeno	4,1	µg/l
CA 125	neprovedeno	48 ↑	kU/l

Moč 1. 9.: bilirubin ++, leukocyty ++, sediment leukocyty 65/µl; kultivace E. coli 10^4 CFU/ml (signifikance hraniční). Zdroje: 02 Laboratoř LabJih 1. 9. 2026, 10 Laboratoř KOC Nemocnice Lipová 15. 10. 2026.

14 Histologie

B-2026/15921 (vydáno 19. 10. 2026): duktální adenokarcinom pankreatu G2–G3 s perineurální invazí, CK7+, CK19+, CK20−, CDX2−, SMAD4 zachován, MKN-O 8500/3.

> **NESOULAD: materiál „odběr 20. 10. 2026“ je po datu vydání 19. 10. i po výkonu 12. 10. – ověřit u patologie**

Zdroj: 11 Histologie KOC 2 19. 10.

15 Jiná důležitá sdělení včetně přání pacienta

Pacientka je informována o podezření na nádorové onemocnění a souhlasí se sdílením informací s dcerou Petrou Horkou. Vdova, žije sama, dcera v téže obci. Výrazná úzkost – PL žádá psychologickou podporu (psycholog a algeziolog objednáni, zprávy budou až po MDT). Biliární drenáž v dostupných zprávách nedoložena.

> **POZNÁMKA: zprávy 12 (algeziologie 26. 10.) a 13 (psychologie 27. 10.) vznikly po MDT – do podkladu nezahrnuty**

Zdroj: 07 Žádost PL 2. 10. · 04 Epikríza PL 4. 9.

Bc. Lucie Dvořáková, koordinátorka KOC Nemocnice Lipová · 20. 10. 2026